

УДК:616-0066-08

С.Е.Есентаева, М.Р.Кайрбаев, Ш.Ж.Талаева, А.К.Туманова, М.А.Кузикеев
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Коррекция анемического синдрома у онкологических пациентов

Аннотация. В условиях Казахского НИИ онкологии и радиологии была проведена клиническая апробация применения препарата Венофер® для коррекции железодефицитной анемии у онкологических больных.

В исследование были включены 40 онкологических больных с анемией средней и тяжелой степени тяжести.

Полученные результаты о применении Венофера (сахарата железа) делают препарат весьма перспективным в лечении анемии у онкологических больных, позволят проводить более короткий и безопасный курс лечения без применения гемотрансфузии, кроме этого сокращает применение ЭПО препаратов.

Ключевые слова: онкологические больные, железодефицитная анемия, Венофер.

Анемия - клинико-гематологический синдром, характеризующийся снижением концентрации гемоглобина и (в большинстве случаев) эритроцитов в единице объема крови. У онкологических больных скрытый или явный дефицит железа обнаруживается постоянно, возникающий как вследствие развития опухолевого процесса, так и вследствие проведения противоопухолевой терапии. Частота встречаемости анемии у первичных онкологических больных составляет порядка 30% [1,2]. Наличие ЖДА ухудшает качество жизни больных и лимитирует проведение адекватной и эффективной противоопухолевой терапии, что увеличивает относительный риск смертности среди онкологических больных на 65% [CellaD., 1998]. Кроме этого, осложнения противоопухолевой терапии снижают качество жизни, а некоторые из них (такие как гемотоксичность, нефротоксичность и кардиотоксичность) представляют непосредственную угрозу для жизни пациента, также противоопухолевая терапия индуцирует анемию более чем у 60% пациентов. Причин такой высокой частоты анемии у онкологических больных несколько. Часть из них наблюдается и в общей популяции (дефицит железа, витаминов, почечная недостаточность и т.д.). Однако некоторые из причин являются «специфичными» для онкологической практики: кровотечение из опухоли, опухолевое поражение костного мозга, анемия опухолевого заболевания и токсичность противоопухолевого лечения [3].

В зависимости от уровня гемоглобина в крови Всемирная организация здравоохранения, Национальный институт рака США и ряд других организаций пользуются классификацией анемии по следующим критериям: легкая анемия — уровень Hb от 100 г/л до нормального; анемия средней тяжести — уровень Hb от 80 до 100 г/л; тяжелая анемия — от 65 до 79 г/л и анемия, угрожающая жизни, — уровень Hb < 65 г/л. Нормальным уровнем гемоглобина принято считать 12 г/дл у женщин и 13 г/дл у мужчин. По данным, полученным в результате

полугодового наблюдения более чем за 15 тыс. больных с разными новообразованиями в Европе в 2001 г. (European Cancer Anaemia Survey – ECAS), анемия осложняла течение опухоли у 39% пациентов. В 35% случаев она присутствовала уже при постановке диагноза, у 48% больных со стабилизацией и рецидивом заболевания и в 1/3 (31%) случаев — у больных в ремиссии [4]. В этом же исследовании ECAS продемонстрировано, что частота анемии на фоне лучевой терапии составляет 28% по сравнению с 50% у пациентов, получающих химиотерапию — ХТ (причем в 77% этих случаев лечение включало препараты платины) [5]. Своевременное выявление ЖДА и эффективная терапия устраняет анемические проявления и тем самым улучшает качество жизни онкологических больных и увеличивает продолжительность их жизни [6].

Химиотерапия приводит к снижению уровня гемоглобина крови при всех видах злокачественных опухолей. Использование в лечении платиносодержащих режимов — достоверный прогностический фактор развития анемии. Больным с исходно низким уровнем гемоглобина требуются гемотрансфузии при последующем лечении. Несомненно, гемотрансфузия показана при угрожающих жизни состояниях: острой кровопотере, тяжелой анемии. Однако анемия злокачественного процесса, как правило, носит хронический характер, а частые гемотрансфузии существенно увеличивают риск возникновения побочных эффектов. Эритропоэзстимулирующие препараты (ЭПО) применяются в лечении анемии. В 1/3 случаев анемии, вызванной химиотерапией, не удается добиться ответа на лечение ЭПО, а у остальных ответ на лечение может проявиться через несколько недель. При анемии, вызванной онкологическим заболеванием, внутривенное (но не пероральное) применение препаратов железа улучшает ответ на применение ЭПО. Такая особенность терапии ставит вопрос о поиске новых эффективных и безопасных препаратов железа.

Одним из таких препаратов является сахарат железа (Венофер®), успешно применяемый у больных с ЖДА в связи с высокой эффективностью, низкой токсичностью, безопасностью в послеоперационном или послеродовом периоде, у больных с хронической почечной недостаточностью, требующей гемодиализа. Эффективность препарата сахарата железа доказана на большом клиническом материале в проспективных контролируемых рандомизированных исследованиях. Очень низкая частота возникновения анафилактических реакций была подтверждена исследованием, проходившем в 61 центре США [7].

В условиях Казахского Научно Исследовательского института онкологии и радиологии была проведена клиническая апробация применения препарата Венофер® для коррекции железодефицитной анемии у онкологических больных.

Таблица - Динамика повышения показателей крови

Группы пациентов	Тяжесть анемии	Критерии анемии	Исходные параметры	Динамика изменений исходных показателей	
				Через неделю	2-3-я неделя терапии
Число пациентов (n=40)	Средней степени	Гемоглобин	84±5,2г/л	90±3,4г/л (+7,14%)	117±1,4г/л (+39,3%)
		Сыв. железо	8,2±1,7мкмоль/л	10,8±1,4мкмоль/л (+31,7%)	12,1±0,9мкмоль/л (+47,5%)
		Эритроциты	3,45·10 ¹² ±0,06/л	3,64·10 ¹² ±0,05/л (+5,5%)	3,7·10 ¹² ±0,05/л (+7,2%)
		Цв.показатель	0,85±0,06	0,87±0,04 (+2,3%)	0,87±0,04 (+2,3%)
	Тяжелой степени	Гемоглобин	68±7,4г/л	80±6,3г/л (+17,6%)	105±2,8г/л (+54,4%)
		Сыв. железо	6,8±1,4мкмоль/л	10,3±0,9мкмоль/л (+51,4%)	12,3±0,7мкмоль/л (+80,8%)
		Эритроциты	3,0·10 ¹² ±0,04/л	3,38·10 ¹² ±0,06/л (+12,6%)	3,5·10 ¹² ±0,06/л (+16,7%)
		Цв.показатель	0,84±0,04	0,86±0,05 (+2,4%)	0,87±0,04 (+3,5%)

Материалы и методы

В исследование включены 40 онкологических больных с анемией средней и тяжелой степени тяжести. Основным критерием включения в группу служили: снижение гемоглобина (Hb<110 г/л), наличие гипохромии (цветовой показатель <0,85) и микроцитоза, снижение уровня сывороточного железа менее нижней границы нормы (<10 мкмоль/л для женщин и <12,5 мкмоль/л для мужчин). В среднем по группе уровень гемоглобина был снижен до 87,8±0,4 г/л, средняя длительность анемии составляла 1,5±2 года. Причины анемии: полихимиотерапия в 70% случаев, острая или хроническая кровопотеря – 20%, другие или комбинированные причины в 10% случаев. 60% больных были женщины и 40% - мужчины. Средний возраст составлял 45±2,6 лет. Распределение больных по онкопатологии было следующим: 70% - рак молочной железы и онкогинекология, 10% - опухоли головы и шеи, 20% - колоректальный рак. Длительность онкозаболевания у 70% больных составила в среднем 10±6 месяцев. Анемические симптомы у этой группы пациентов были обусловлены развитием опухолевого процесса, кровопотерями после проводимых операций, так и проводимой химиотерапией. Химиотерапия включала в среднем 4±1,3 курсов преимущественно антрациклиновые антибиотики и платиносодержащие препараты.

В 90% случаев пациенты внутривенно получали сахарат железа, 3 мг/кг в день, в виде 30 минутной инфузии, общая доза рассчитывалась по формуле согласно инструкции время лечения 5-6 дней. Повышение уровня гемоглобина составило 3,6±0,8 г/л в день, что оказалось статистически достоверно (p=0,003) (см таблицу). Переносимость сахарозного комплекса железа пациентами была хорошей, побочных явлений и аллергических реакций не отмечено.

По полученным данным видно, что в группе больных с исходной анемией средней степени (Hb 90±3,4г/л) прирост гемоглобина через 1 неделю после приема препарата Венофер в дозе 100-200 мг в сутки составил +7,14%, а через 2-3 недели терапии – +39,3%. Прирост сывороточного железа составил +31,7% -через неделю и +47,5% - через 2-3 недели приема.

В группе женщин с исходной тяжелой степенью

анемии (Hb 68±7,4г/л) прирост гемоглобина через 2-3 неделю приема препарата Венофер в дозах 200-300 мг в сутки составил +6,6%, прирост сывороточного железа составил +80,8%.

Отрицательной лабораторной динамики (снижение показателей сывороточного железа и /или гемоглобина) не было отмечено ни у одного пациента.

В 10% случаев применялась комбинированная терапия внутривенным сахаратом железа и рчЭПО у пациентов с уровнем гемоглобина ниже 100 г/л (у пациентов с менее тяжелой анемией и уровнем Hb

от 100 до 120 г/л по клиническими обстоятельствами рчЭПО не применялись). Монотерапия ЭПО препаратами назначается пациентам с тяжелой анемией и применяется три раза в неделю (в дозе 150 МЕд/кг) на протяжении как минимум 4 недель. Комбинированная терапия сахаратом железа и рчЭПО позволяет сокращать сроки терапии, быстро наступает клинический ответ. В качестве клинического примера приводим результаты лечения 55-летней пациентки, оперированной по поводу рака шейки матки. Показатели гемоглобина выросли с 65 г/л до 118 г/л за быстрое время 1 месяц на фоне комбинированной терапии рчЭПО (по 10000 ЕД, подкожно, в дни 3, 5 и 7) и внутривенным сахаратом железа (по 100-200 мг, 6 введений, в дни 2, 6, 9, 18, 20, 24). Трансфузии эритроцитарной массы не применялись.

Полученные результаты о применении Венофера (сахарата железа) делают препарат весьма перспективным в лечении анемии у онкологических больных, позволят проводить более короткий и безопасный курс лечения без применения гемотрансфузии, кроме этого сокращает применение ЭПО препаратов.

Список литературы

1. Cella D. Factors influencing quality of life in cancer patients: anemia and fatigue Seminars // *Oncology*.-1998.-Vol. 25, №3 (Suppl 7).-C. 43-46.
2. survival and increased locoregional failure in patients with locally advanced head and neck carcinoma: a secondary analysis of RTOG 85-27// *Int. J. Radiat. Oncol.Biol. Phys.* - 1998.- Vol 561.-C. 1069-1075.
3. Mercadante S., Gebbia V., Marrazzo A. et al. Anaemia in cancer: 2 .Lee W.R., Berkey B., Marcial V. et al. Anemia is associated with decreased pathophysiology and treatment // *Cancer Treat. Rev.*-2000.- Vol 26.-C. 303-311.
4. Ludwig A. et al. // *Eur. J. Cancer.* - 2004.- Vol 40.-C. 2293-2306.
5. Ludwig C. et al. // *Ann. Oncol.*-2002.- Vol. 13. №5.-C. 169, A623PD.
6. Demetri C.D., Kris B., Wade J. et al. Quality of life benefit in chemotherapy patients treated with epoetin alfa is independent of disease response of tumor type; Results from a prospective community oncology study // *J. Clin. Oncol.*-1998.- Vol. 16, №10.-C. 3412-3425.
7. Van Wyck D.V., Cavallo G., Spinowitz B.S. et al. Safety and efficacy of iron sucrose in patients sensitive to iron dextran: North American clinical trial // *Am. J. Kidney.* - 2000.- Vol 36.-C. 88-97.

Тұжырым

С.Е.Есентаева, М.Р.Кайрбаев, Ш.Ж.Талаева,
А.К.Туманова, М.А.Кузикеев

Қазақтың онкология және радиология ғылымф
зерттеу институты

Онкологиялық науқастардағы анемия синдромының
коррекциясы

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-
зерттеу институтында Венофер® препаратын
теміртапшылықты анемиясы бар онкологиялық
науқастарға қолдану барысында клиникалық апробация
жүргізілді.

Зерттеуге анемиясы орта және ауыр сатыдағы 40
онкологиялық науқастар алынды. Алынған қорытындылар
Венофер® (қант темір) препаратын қолдану арқылы
онкологиялық науқастардың анемиясын алдын ала
емдейді, гемотрансфузияді қолданбай анағұрлым қысқа
және қауіпсіз курс жүргізуге мүмкіндік береді, бұдан
басқа ЭПО препаратын қолдануды қысқартады.

Түйді сөздер: онкологиялық науқастар,
теміржетіспеушілік анемия, Венофер.

Summary

S.E.Yesentayeva, M.R.Kayrbaev, S.Z.Talaeva,
A.K.Tumanova, M.A.Kuzikeev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Correction of anemia in cancer patients

In the Kazakh Research Institute of Oncology and Ra-
diology was conducted clinical testing of the Venofer® for
correction of iron deficiency anemia in cancer patients. The
study included 40 cancer patients with anemia secondary to
severe. The obtained results are making Venofer® (iron su-
crose) as a promising drug in the treatment of anemia in cancer
patients, should allow a shorter and safer treatment without
of using blood transfusion, and reduce the use of colony-
stimulating factors.

Keywords: cancer patients, iron deficiency anemia,
Venofer.